



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : ثريا عبدالستار حسن ابراهيم

العنوان : ..

الحي / المدينة : مغاغة

المحافظة : المنيا

تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

رقم البطاقة : 26504232401288 رقم التليفون : 01146468138

العمر (تاريخ الميلاد) : 23-04-1965 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ثريا عبدالستار حسن ابراهيم National ID: 26504232401288	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٠١٠٥٧٣٣٢١٧
٠١١٤٦٤٦٨١٣٨



Pat. Name Thoraya Abd Elsattar	Pat. Age 61 Y
--------------------------------	---------------

Examination: LEFT breast US.

Dear prof. Thank You for your patient refer,
Examination of your patient revealed that

Clinical summary:

61 year old female patient with -ve family history for breast cancer, complaining of left breast lump

Impression:

Left breast..... Multi centeric breast lesion (US Score V)... for biopsy

*** locally advanced left sided upper inner quadrant Suspicious breast lesion with deep infiltration of underlying muscle and superficial extension to nipple with subsequent nipple retraction.

*** Other suspicious axillary tail lesion.

**No suspicious axillary nodes.

As regarding the left side:

- There is large ill-defined hypo echoic irregular soft tissue mass lesion seen at the upper inner quadrant. It is seen opposite 10 O'Clock. It is seen measuring 4x3cm. with foci of calcification within, On application of color Doppler, its shows internal vascularity. it is seen partially invading the underlying muscle. And also shows direct extension to the main lactiferous duct and nipple which is seen retracted with mild induration within. Mild thickening of the overlying skin is also noted.
- Another ill defined hypoechoic lesion is seen at axillary tail, measuring about 14x14mm, with speculated margins.
- Few non specific axillary lymph node are noted, all with intact fatty hilum and preserved architecture.
- Intact axillary vessels.



9/12/2026

359994|6423|

GUSTAVE/
ROUSSY
INTERNATIONAL
LABORATORY

Centre d'Analyse et de Pathologie
Internationale - 25, rue de la
Liberté - 92100 Nanterre - France

أشرف
روسي
مختبر
البيولوجيا
المختبرية

Patient Name	نوريا عبداللطيف حسن	Case No.	359994
Sex/Age	Female 61 Y	Patient No.	25777
Registered Date	23/8/2026 02:39:07 PM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	07/9/2026 01:03:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	12/9/2026 09:39:25 AM	Pathology No.	2546/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS V).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 12/08/2026. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Multiple fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): 2%.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 99% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 99% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in less than 10% of tumor cells (score 0+).
- Ki67%: 15%.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).



مختبر
أشرف
روسي
مختبر
البيولوجيا
المختبرية
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corridor - Mitter El Qadema - Cairo, Egypt

GUSTAVE/
ROUSSY/
INTERNATIONAL
LABORATORYGustave Roussy International - Egypt - Pathology Lab
جوستاف روسي الدولي - مصر - مختبر الأمراضجوستاف روسي
Gustave Roussy
International Laboratory

Patient Name	ثريا عبدالستار حسن	Case No.	359994
Sex/Age	Female 61 Y	Patient No.	25777
Registered Date	23/8/2026 02:39:07 PM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	07/9/2026 01:03:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	12/9/2026 09:39:25 AM	Pathology No.	2546/26

- P-R: Positive (score 8/8).
- Her2: Ultra-low (score 0+).
- Ki67%: 15%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature**Prof. Dr. Maha Guinei, MD, PhD.****Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim, MD.**

عقبة رقم (14) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - محور قنطرة - القليوبية - 35999 - مصر
Room No. (14) - First Floor-Building No. 987 - Nile Corniche - Minr El Qadima - Cairo, Egypt

دكتورة

نشوى محمد عادل

دكتورة واستشاري الأشعة التشخيصية
وقصورات الأجنة - جامعة المنيا

لهي سكيان

أول مذكر طبي متخصص في جميع الشععات المرادة

Pat. Name	Thoraya Abd Elsattar	Pat. Age	61 Y
-----------	----------------------	----------	------

Examination: LEFT breast US.

Dear prof. Thank You for your patient refer,
Examination of your patient revealed that

Clinical summary:

61 year old female patient with -ve family history for breast cancer, complaining of left breast lump

Impression:

Left breast..... Multi centeric breast lesion (US Score V)... for biopsy

*** locally advanced left sided upper inner quadrant Suspicious breast lesion with deep infiltration of underlying muscle and superficial extension to nipple with subsequent nipple retraction.

*** Other suspicious axillary tail lesion.

***No suspicious axillary nodes.

As regarding the left side:

- There is large ill-defined hypo echoic irregular soft tissue mass lesion seen at the upper inner quadrant. It is seen opposite 10 O' Clock. It is seen measuring 4x3cm. with foci of calcification within, On application of color Doppler, it shows internal vascularity. it is seen partially invading the underlying muscle. And also shows direct extension to the main lactiferous duct and nipple which is seen retracted with mild induration within. Mild thickening of the overlying skin is also noted.
- Another ill defined hypoechoic lesion is seen at axillary tail, measuring about 14x14mm, with speculated margins.
- Few non specific axillary lymph node are noted, all with intact fatty hilum and preserved architecture.
- Intact axillary vessels.